

9. 94. Darolutamide(如 Nubeqa)：(110/11/1、112/9/1、113/5/1、113/8/1、115/4/1)

1. 作為單一療法或與 docetaxel 併用於治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，總療程以36個月為上限。(113/5/1、114/6/1、115/4/1)

(1)須經事前審查核准後使用。

(2)每3個月需再次申請，再申請時若 PSA 值下降未超過治療前的50%以上，則需停藥。

(3)下降達最低值後之持續追蹤出現 PSA 較最低值上升50%以上且 $PSA \geq 2\text{ng/mL}$ ，則需停藥，但影像學證據尚無疾病進展者，可以繼續使用。

(4)前述高風險需符合下列三項條件中至少兩項(113/5/1、113/8/1)：

I. 葛里森分數(Gleason score) ≥ 8 。

II. 骨骼掃描出現三個(含)以上病灶且至少其中一處以上為非脊柱及非骨盆腔轉移。(113/5/1、113/8/1)

III. 出現內臟轉移。

(5)與 docetaxel 併用，docetaxel

限使用6個療程，且須符合下列所有條件：

I. ECOG ≤ 1 。

II. 絕對嗜中性球計數 $\geq 1500/\text{mm}^3$ 。

III. 血小板計數 $\geq 100,000/\text{mm}^3$ 。

IV. GPT ≤ 2 倍之正常值上限。

V. Total bilirubin $\leq$ 正常值上限。

VI. eGFR $\geq 30\text{mL/min/1.73m}^2$

2. 治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。

(1)須經事前審查核准後使用。

(2)初次申請時需檢附病理報告、使用雄性素去除療法紀錄，系列 PSA 和睪固酮數據，三個月內影像報告證明無遠端轉移。

(3)ECOG 分數須 ≤ 1 。

(4)PSA doubling time ≤ 10 個月，PSA 倍增之時間，應依線性回歸模型計算，且其參數取得需基於下列原則：(112/9/1)

I. 至少三個連續 PSA 測量值，且各測量值皆 $\geq 0.2 \text{ ng/mL}$ （最高的 PSA 值必須 $>1.0\text{ng/mL}$ ）。

II. 應包含先前 ADT 治療期間的測量值，且最少一測量值為最近3個月內測得之 PSA 數值。

III. 第一個和最後一個 PSA 測量值間隔需 ≥ 8 週，但 ≤ 12 個月。

(5)每3個月需再次申請，申請之療程以3個月為限。再次申請時，有 PSA progression 者，需檢附影像學報告，若影像學報告證實轉移，則需停藥；無 PSA progression 者，則每6個月需檢附影像學報告，若影像學報告證實轉移，則需停藥。(112/9/1)

註：

PSA progression 定義為:PSA 下降 達最低值(nadir)後，出現 PSA 值上升較 nadir $\geq$ 25%，且 PSA $\geq$ 2 ng/mL，並於至少3週後，再次抽血 確認 PSA 值有上升趨勢。

3. 不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide 和 enzalutamide)，及 olaparib 與 abiraterone 併用，終生僅給付一種治療，且除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療，不得互換。(112/9/1、114/6/1)